

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE TRASTORNOS DEL HUMOR (MDQ)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Cribado de Trastorno Bipolar y Detección de Episodios Hipomaniacos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Trastornos del Humor (MDQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Mood Disorder Questionnaire (MDQ)</i>
Autores Originales	Robert M. A. Hirschfeld, Joseph R. Calabrese, Laurie Flynn, Paul E. Keck Jr., Lydia Lewis, Robert M. Post y cols. (2000).
Adaptaciones Españolas	Saiz, Bousoño, Bascarán et al. (2003, validación de referencia); Bobes et al. (2004, Ars Medica / CIBERSAM).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado sindrómico de bipolaridad (I, II y ciclotimia).
Tipo de Instrumento	Autoinforme estructurado en 3 partes: 13 síntomas hipomaniacos (Sí/No), concurrencia temporal e impacto funcional.
Población y Rango	Adultos y adolescentes (>= 15 años). Pacientes con sintomatología depresiva en salud mental y primaria.
Tiempo de Administración	5 a 7 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación médica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y EL RETO DEL INFRADIAGNÓSTICO BIPOLAR

El MDQ fue creado por Hirschfeld y colaboradores (2000) bajo el auspicio de la American Psychiatric Association con el objetivo específico de mitigar el grave **infradiagnóstico y retraso terapéutico** característico del Trastorno Bipolar (estimado clínicamente entre 8 y 10 años desde el inicio de los síntomas). La inmensa mayoría de los pacientes bipolares buscan atención clínica durante fases depresivas, omitiendo espontáneamente sus episodios hipomaniacos previos por vivenciarlos como períodos de bienestar, alta productividad o inspiración personal.

El instrumento evalúa de manera retrospectiva si en algún momento de la biografía el sujeto ha experimentado un viraje del humor hacia la euforia o irritabilidad patológica acompañado de aceleración psicomotora y desinhibición conductual. La inclusión obligatoria de criterios de **co-ocurrencia temporal** y **repercusión psicosocial** permite filtrar fluctuaciones normales del temperamento, maximizando la especificidad diagnóstica.

3. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL MDQ (HIRSCHFELD ET AL., 2000)

Sección del Cuestionario	Ítems	Opciones	Contenido y Significación Semiológica
Parte 1: Síntomas Maníacos	1 al 13	Sí / No (0-13)	Euforia, irritabilidad, grandiosidad, hiposomnia sin cansancio, taquialia, fuga de ideas, distractibilidad, hiperactividad, gastos desmedidos e impulsividad sexual.
Parte 2: Simultaneidad	1 ítem	Sí / No	Determina si varios de los síntomas afirmados ocurrieron juntos durante un mismo episodio temporal.
Parte 3: Deterioro Funcional	1 ítem	4 niveles	Magnitud de las dificultades ocasionadas: Ningún problema, Problema menor, Problema moderado o Problema serio.
RESULTADO DEL CRIBADO	3 criterios	Positivo/ Neg.	Identificación formal de sospecha fundada de Trastorno del Espectro Bipolar.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Sensibilidad y Especificidad	En la validación clínica española de Saiz et al. (2003), el punto de corte estándar demostró una sensibilidad global del 73% y una especificidad del 90% frente a entrevistas estructuradas (SCID).
Rendimiento por Subtipo	Excelente sensibilidad para Trastorno Bipolar Tipo I (85%), y moderada para Trastorno Bipolar Tipo II (58-65%), donde la hipomanía suave suele requerir heteroinformes.
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.83 a 0.86 para los 13 ítems sintomáticos de la Parte 1 en muestras psiquiátricas ambulatorias.
Validez Discriminante	Diferencia de manera robusta entre pacientes con Depresión Mayor Unipolar y aquellos con Trastornos del Espectro Bipolar (Bipolar I, II y Ciclotimia).
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación kappa de 0.81 tras tres semanas en pacientes ambulatorios en fase eutímica o depresiva estable.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CRITERIO TRIPARTITO DE POSITIVIDAD

Para que un protocolo del MDQ sea clasificado como **CRIBADO POSITIVO PARA TRASTORNO BIPOLAR**, deben cumplirse simultáneamente los tres criterios siguientes:

- **Criterio 1 (Conteo Sintomático):** Responder afirmativamente (**SÍ**) a **7 o más** de las 13 cuestiones de la Parte 1.
- **Criterio 2 (Simultaneidad Temporal):** Responder afirmativamente (**SÍ**) a la Parte 2 (los síntomas ocurrieron en el mismo período).
- **Criterio 3 (Interferencia Funcional):** Indicar en la Parte 3 que los síntomas ocasionaron un problema **MODERADO** o **SERIO** (laboral, relacional, financiero o legal).

POSITIVO = (>= 7 Síntomas en P1) Y (Simultaneidad en P2) Y (Problema Moderado o Serio en P3)

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y SIGNIFICACIÓN ASISTENCIAL

Resultado	Criterios	Estado Diagnóstico Probable	Conducta Asistencial Recomendada
Negativo	No cumple los 3 requisitos	Baja probabilidad de trastorno bipolar típico	Si consulta por depresión, orientar como Depresión Unipolar. Monitorizar respuesta a fármacos.
Bipolaridad Blanda	>= 7 síntomas, pero sin disfunción	Posible espectro bipolar blando / Hipertimia	Reevaluar con informantes colaterales (pareja/padres). Evitar dosis altas de antidepresivos.
Positivo	Cumple los 3 requisitos	Cribado Positivo (Espectro Bipolar)	Evaluación psiquiátrica inmediata para confirmación diagnóstica y pauta con estabilizadores del ánimo.

MODULACIÓN DEL UMBRAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: En medicina de familia, rebajar el umbral a *≥6* síntomas sin exigir obligatoriamente interferencia sería eleva la sensibilidad al 88%, reduciendo el riesgo de prescribir antidepresivos en monoterapia a pacientes bipolares enmascarados.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y PREVENCIÓN DE VIRAJE

DECISIÓN CLÍNICA ANTE EPISODIO DEPRESIVO EN CONSULTA:

- **Paso 1:** Ante todo paciente con clínica depresiva resistente, recurrente o de inicio temprano (< 25 años), administrar obligatoriamente el MDQ antes de instaurar antidepresivos.
- **Paso 2 (MDQ Positivo):** Contraindicada la monoterapia con ISRS o duales por alto riesgo de viraje maniaco agudo o ciclación rápida. Derivar a Psiquiatría para inicio de eutimizantes (litio, valproato, lamotrigina) o antipsicóticos atípicos aprobados para depresión bipolar (quetiapina, lurasidona).
- **Paso 3 (MDQ Dudoso en Bipolar II):** Si la sospecha clínica persiste pero el MDQ es negativo por anosognosia de la hipomanía, aplicar la escala BSDS y entrevistar a la pareja o familiares directos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN ANTE DEPRESIÓN RESISTENTE

Paciente: Varón de 36 años, arquitecto, que consulta por su tercer episodio depresivo mayor en 4 años, actualmente en tratamiento con sertralina 100 mg/día sin mejoría tras 8 semanas, experimentando irritabilidad paradójica e insomnio tardío.

Resultados MDQ:

- **Parte 1:** Marca 9 de los 13 síntomas afirmativos (euforia desmedida, necesitar dormir solo 3 horas sintiéndose pletórico, taquialia, gastos impulsivos en inversiones arriesgadas y aumento desmesurado de la libido).
- **Partes 2 y 3:** Simultaneidad confirmada en un período de 10 días hace dos años; califica el impacto como **Problema Moderado** (conflictos conyugales por celotipia y gastos excesivos con tarjeta).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno Bipolar Tipo II con episodio depresivo actual y viraje disfórico subintrante por antidepresivos. Se retira gradualmente la sertralina y se instaura tratamiento con carbonato de litio asociado a lamotrigina. A las 6 semanas se alcanza la eutimia sin ciclación y con estabilización del patrón circadiano de sueño.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DERIVACIÓN URGENTE

ALERTA: VIRAJE Y CONDUCTA TEMERARIA

El paso inadvertido de depresión a manía franca conlleva riesgo de ruina económica, accidentes y transgresiones legales. El clínico debe advertir formalmente al entorno familiar sobre signos precoces de aceleración psicomotora.

ALTO RIESGO AUTOLÍTICO EN FASES MIXTAS

Los estados mixtos (ánimo depresivo con agitación y aceleración cognitiva del MDQ) multiplican exponencialmente la letalidad suicida por incremento de la impulsividad motora.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Hirschfeld, R. M., Williams, J. B., Spitzer, R. L., Calabrese, J. R., Flynn, L., Keck, P. E., Lewis, L., McElroy, S. L., Post, R. M., Rapoport, D. J., Russell, J. M., Sachs, G. S., & Zajecka, J. (2000). Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. *American Journal of Psychiatry*, 157(11), 1873–1879.
2. Saiz, P. A., Bousño, M., Bascarán, M. T., Corominas, A., & Bobes, J. (2003). Validación de la versión española del Cuestionario de Trastornos del Humor (MDQ). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 31(Supl 1), 60–66.
3. Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica.
4. Zimmerman, M., & Galione, J. N. (2011). Screening for bipolar disorder with the Mood Disorders Questionnaire: a review. *Harvard Review of Psychiatry*, 19(5), 219–228.